

ONICOMICOSIS

Rubén Linares Navarro, Paula Fernández Canga, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La onicomicosis es la infección fúngica de las uñas. Los agentes causales más frecuentes son los dermatofitos (en torno al 68% del total de las onicomicosis, en especial *Trichophyton rubrum*), seguido de las levaduras (29%, destacando *Candida Albicans*) y de los mohos no dermatofitos (3%).

Los factores de riesgo de onicomicosis incluyen: diabetes mellitus, inmunosupresión, edad avanzada, tiña pedis (por diseminación), psoriasis, hiperhidrosis, obesidad y humedad local, ya sea por motivos ocupacionales, deporte o calzado oclusivo.

Las onicomicosis se clasifican según la zona anatómica afectada:

- Subungueal distal y externa (Fig.4 y Fig. 5): la más común. Consiste en una decoloración amarillenta, blanquecina o marronácea de la parte distal de la uña que va extendiéndose hacia toda la placa ungueal. Presenta hiperqueratosis subungueal y onicolisis.
- Blanca superficial: punteado o parche blanquecino en la placa ungueal.
- Subungueal proximal: se relaciona con inmunodepresión grave. Comienza como una mancha blanquecina a nivel del pliegue ungueal proximal que puede llegar a la lúnula y la parte proximal de la placa ungueal.



Figura 4: Onicomicosis subungueal distal y externa.



Figura 5: onicomicosis subungueal distal y externa.

DIAGNÓSTICO.

El diagnóstico clínico ha de confirmarse mediante examen en fresco con KOH (hidróxido potásico) o cultivo.

Ha de plantearse el diagnóstico diferencial con la psoriasis y la distrofia ungueal.

TRATAMIENTO:

Es conveniente confirmar el diagnóstico previamente al tratamiento.

Entre los fungicidas tópicos se emplea:

- **Amorolfina ISDIN 50mg/ml barniz de uñas:** aplicar en uñas de pies o manos 1 o 2 veces a la semana durante 6 meses, limar y limpiar con alcohol antes de aplicar la laca. Usar guantes

para realizar procedimiento.

- **Ciclopiroxolamina en laca ungueal** (2 aplicaciones a la semana durante al menos 6 meses para las uñas de las manos y hasta 1 año para las de los pies).

El antifúngico sistémico más empleado es:

- **Terbinafina 250mg vía oral:** 250mg/día durante 6 semanas en manos y 12 semanas en pies.
- Otras opciones terapéuticas son los **azoles** sistémicos en pauta intermitente.

En casos leves, el tratamiento tópico puede ser suficiente, aunque por ser prolongado, tiene mala adherencia. En casos moderados-graves el tratamiento de elección será sistémico e incluso combinado.

BIBLIOGRAFÍA

- Vañó S, Jaén Olasolo P. Dermatología. Madrid: Medical & Marketing Communications; 2016.
- Saunte DML, Piraccini BM, Sergeev AY, Prohić A, Sigurgeirsson B, Rodríguez-Cerdeira C et al. A survey among dermatologists: diagnostics of superficial fungal infections – what is used and what is needed to initiate therapy and assess efficacy? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019;33(2):421-427.
- Ameen M, Lear JT, Madan V, Mohd Mustapa MF, Richardson M. British Association of Dermatologists' guidelines for the management of onychomycosis 2014. Br J Dermatol. 2014;171(5):937-58.
- Sigurgeirsson B, Baran R. The prevalence of onychomycosis in the global population - A literature study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014;28(11):1480-91.
- Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K. Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General. 8ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2014.